

HEMORRAGIA DIGESTIVA BAJA

Victoria Cano López, Estefania Bay, Jorge Jesús Morais García, Rudiger Carlos Chavez Flores, Julio Tito Camino Acha.

INTRODUCCIÓN

La hemorragia digestiva baja (HDB) es la pérdida de sangre por el tubo digestivo cuyo origen es distal al ligamento de Treitz. Representa aproximadamente el 20-25% de todos los casos de hemorragia digestiva, con una incidencia de 20-37 casos/100 000 habitantes, y su prevalencia ha aumentado en los últimos años. La mayoría de los casos ocurren en paciente de edad avanzada con comorbilidades asociadas. Las causas más frecuentes en nuestro medio son la diverticular y la colitis isquémica. Otras causas son hemorroides, tumores, colitis actínica, colitis infecciosa, fisura anal y enfermedad inflamatoria intestinal (Figura 1).

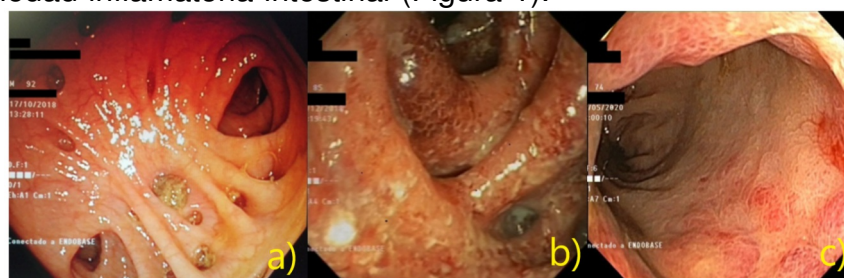


Figura 1: Imágenes endoscópicas de las principales causas de hemorragia digestiva en nuestro medio (A. Diverticulosis colónica marcada. B. Colitis isquémica. C. Proctitis actínica)

DIAGNÓSTICO

Clínica. Se Puede Manifiestar Como:

- Sangre de color rojo vivo, que recubre las heces o aparece tras la defecación de heces normales o mancha el papel higiénico: origen anorrectal.
- Sangre de color rojo oscuro o granate, mezclada con las heces o como único componente de la defecación: origen no hemorroidal.
- Melenas: sugieren HDA, pero pueden ser la forma de presentación de una hemorragia de intestino delgado o colon derecho.

Anamnesis

- Episodios previos
- Fuentes de sangrado descritas previamente.
- Enfermedades o factores de riesgo cardiovascular.
- Uso de fármacos (AINE, antiagregantes o anticoagulantes).
- Radioterapia pélvica.
- Endoscopias o cirugías previas.
- Síntomas que orienten a determinar el origen.
- Asintomática: origen diverticular.
- Dolor abdominal y diarrea: colitis.
- Síntomas anorrectales patología a ese nivel.
- Alteración del tránsito intestinal o síntomas constitucionales: neoplasia.
- Valorar estado hemodinámico del paciente (palidez cutaneomucosa, sudoración, frialdad en las extremidades, taquicardia, PAS<100 mmHg).
- Exploración general y anorrectal para valorar la presencia de fisuras, hemorroides, masas rectales, características de las heces y sangrado.

Exploración Física

- Constantes vitales, estado de volemia y nivel de consciencia. Se puede utilizar el Índice de Shock ($SI = \text{Pulso} / \text{PAS}$) para calcular si el paciente está estable y sangrando activamente (ver algoritmo de actuación, figura 3).
- Tacto rectal con inspección anorrectal.
- Descartar HDA (10-15%): Paciente inestable, con hipotensión ortostática y cociente urea/creatinina >30 . No coágulos en las heces.

Hipovolemia (% pérdida hemática)	PAS	Pulso	Prueba basculación	Perfusión periférica
Leve ($<10\%$)	>100	<100	-	normal
Moderada (10-25%)	>100	>100	-/+	Frialdad y palidez
Grave (25-35%)	<100	>100	+	Hipoperfusión periférica, oligoanuria o agitación

Tabla 1: Clasificación de la gravedad de la hemorragia digestiva. Gastrointest Endosc 1999; 49: 228-238

Pruebas complementarias en urgencias

- Hemograma,
- Bioquímica general con urea y pruebas de función hepática, PCR.
- Coagulación.
- Radiografía de tórax.
- Electrocardiograma si sospecha de descompensación de patología respiratoria y/o cardiovascular.
- Pruebas cruzadas y reserva de hematíes.

TRATAMIENTO EN URGENCIAS

Medidas generales

- Dos vías periféricas de grueso calibre (16 G) y/o una central.
- Monitorización.
- Transfusión restrictiva: si $\text{Hb} < 7$ g/dl (objetivo 7-9 g/dl), excepto en ancianos o en enfermos con patología cardiorrespiratoria $\text{Hb} < 9$ g/dl (objetivo Hb 10). Si politransfusión ($<3\text{CH}$ en 1 hora) valorar transfusión plasma fresco.
- Sueroterapia: Inicialmente con cristaloides con objetivo de TAS > 100 mmHg.
- Sonda nasogástrica: No se recomienda de rutina. Si se decide su uso debe retirarse tras el primer lavado gástrico.
- **Coagulopatía:** Hemorragia activa con:
 - **Plaquetas $<50\,000$:** transfundir plaquetas.
 - **INR >1.5 :** transfundir plasma fresco o complejo protrombínico.
 - **Si INR 1.5-2.5:** se puede realizar endoscopia antes o concomitante al revertir la coagulación.
 - **Si INR > 2.5 :** se recomienda revertir primero la coagulación.
- Si hay hemorragia digestiva grave que no responde a medidas iniciales, ingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Tratamiento específico

Cesa espontáneamente 80-85%. Se han desarrollado distintas escalas para estratificar el riesgo, como el índice de Okland (figura 2), el Strate o el BLEED.

- **HDB estable con riesgo bajo (autolimitada, sin otra indicación de ingreso, Okland $\leq$ 8):** ALTA con colonoscopia ambulatoria.
- **HDB estable con riesgo alto (Okland $>$ 8):** INGRESO. Colonoscopia urgente, previa preparación, preferentemente dentro de las primeras 24-48 h.
- **HDB con inestabilidad hemodinámica:** INGRESO. Gastroscopia. Si es normal, o no es posible, angioTAC. Si es positiva, se recomienda la angiografía con embolización lo antes posible. En los centros con radiología intervencionista de guardia esto debe completarse dentro de 1 hora.

Edad		PAS	
<40	0	<90	5
40-69	1	90-119	4
≥70	2	120-129	3
Género		130-159	2
Hombre	0	≥160	0
Mujer	1		
Episodio previo de HDB		HB (g/dL)	
NO	0	<7	22
SI	1	7- 8,9	17
Tacto rectal		9-10,9	13
Sangre	0	11-12,9	8
Normal	1	13-15,9	4
Pulso		≥16	0
<70	0		
70-89	1		
90-109	2		
≥110	3		

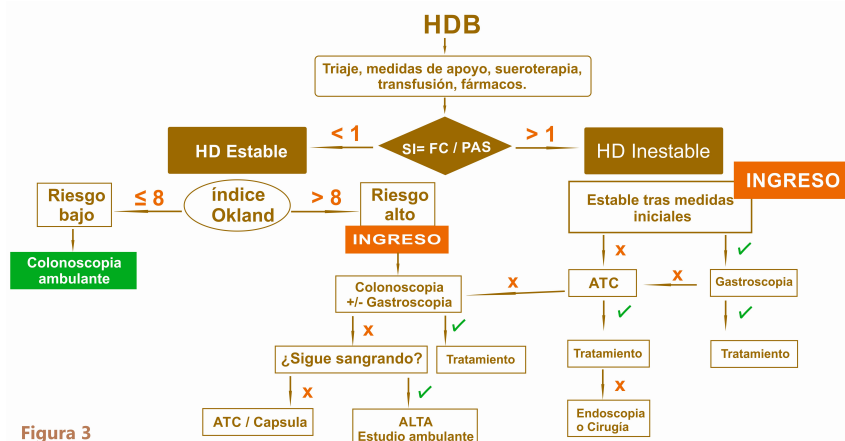
Figura. 2
Índice de Okland

Tratamiento según punto sangrante y etiología:

- Colonoscopia (<24h): HDB sin inestabilidad hemodinámica.
- Angio-TC: HDB con inestabilidad hemodinámica o colonoscopia no concluyente.
- Arteriografía mesentérica: HDB grave, persistente e imposibilidad para realizar colonoscopia.
- Cirugía: HDB masiva, persistente y las anteriores pruebas no han sido concluyentes o que no se hayan podido realizar por la situación clínica del paciente.

Puntos clave

- Valorar el estado hemodinámico inicial con reposición de la volemia o transfusión de sangre según sea necesario.
- Se debe realizar una estratificación del riesgo basada en parámetros clínicos y analíticos para distinguir a los pacientes con bajo y alto riesgo de complicaciones.
- La rectorragia asociada con inestabilidad hemodinámica puede ser indicativa de una fuente de sangrado gastrointestinal superior y, por lo tanto, justifica realizar una gastroscopia.
- En la mayoría de los pacientes la colonoscopia debe ser el procedimiento diagnóstico inicial y debe realizarse dentro de las 24 horas posteriores a la presentación del paciente tras la adecuada preparación del colon.
- Las intervenciones radiológicas deben considerarse en pacientes de alto riesgo con hemorragia activa que no responden adecuadamente a la reanimación y que es poco probable que toleren la preparación intestinal y colonoscopia.
- Se deben evitar el uso de ANES en paciente con antecedentes de sangrado gastrointestinal especialmente si es secundario a diverticulosis o angioectasia.



BIBLIOGRAFÍA

- Almadi MA, Barkun AN. Patient Presentation, Risk Stratification, and Initial Management in Acute Lower Gastrointestinal Bleeding. *Gastrointest Endosc Clin N Am.* 2018; 28(3): 363-77
- Bibiano Gillen, Carlos. Manual de urgencias. Sanidad y Ediciones SL. 2018. ISBN-10: 841683198X p. 484-491.
- Oakland K, Chadwick G, East JE, Guy R, Humphries A, Jairath V, et al. Diagnosis and management of acute lower gastrointestinal bleeding: guidelines from the British Society of Gastroenterology. *Gut.* 2019; 68(5): 776-89.
- Strate, Lisa L.; Gralnek, Ian M. ACG clinical guideline: management of patients with acute lower gastrointestinal bleeding. *The American journal of gastroenterology*, 2016, vol. 111, no 4, p. 459.